TEST 1-2 NORMATIVA SANITARIA

JOSEP MANUEL HERNÁNDEZ

TEST DE 100 PREGUNTAS

Normativa sanitaria común · Temas 1 y 2

Oposición de TES - TEL· Turno libre

Base de elaboración: documentos anexos de los temas 1 y 2, temario de la Resolución de 12 de junio de 2017 y textos normativos consolidados y modificaciones vigentes comprobadas hasta el 18 de julio de 2026.

TEMA 1. Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud

1. ¿Cuál es uno de los objetivos expresos del Real Decreto 1030/2006?

A) Establecer el contenido de la cartera de servicios comunes de las prestaciones sanitarias.
B) Regular exclusivamente la financiación hospitalaria privada.
C) Crear los servicios autonómicos de salud.
D) Determinar las plantillas orgánicas de los hospitales.

2. ¿Qué segundo objetivo básico persigue el Real Decreto 1030/2006?

A) Regular el acceso a la profesión de Técnico en Emergencias Sanitarias.
B) Fijar las bases del procedimiento de actualización de la cartera de servicios comunes.
C) Aprobar el mapa sanitario de cada comunidad autónoma.
D) Establecer el régimen disciplinario del personal sanitario.

3. ¿Cómo define el Real Decreto 1030/2006 la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud?

A) Como el inventario de edificios y vehículos de los servicios de salud.
B) Como la relación de categorías profesionales del Sistema Nacional de Salud.
C) Como el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias.
D) Como el presupuesto anual destinado a la asistencia sanitaria.

4. ¿Quiénes son titulares del derecho a la atención sanitaria a través de la cartera común regulada por el Real Decreto 1030/2006?

A) Únicamente quienes tengan nacionalidad española.
B) Solo las personas empadronadas en la comunidad autónoma que presta la asistencia.
C) Exclusivamente las personas trabajadoras por cuenta ajena.
D) Las personas contempladas en el artículo 3.1 de la Ley 16/2003.

5. ¿Quién determina el procedimiento de acceso a los servicios que hacen efectivas las prestaciones?

A) Las administraciones sanitarias, dentro de sus respectivas competencias.
B) El Consejo General del Poder Judicial.
C) Cada hospital, sin sujeción a normas de la administración sanitaria.
D) Las compañías aseguradoras privadas.

6. Para acceder a una técnica o procedimiento de la cartera común, ¿qué requisito debe concurrir?

A) La petición expresa del paciente, aunque no exista necesidad sanitaria.
B) Una indicación clínica y sanitaria.
C) La autorización del ayuntamiento del domicilio.
D) El pago previo del coste íntegro de la prestación.

7. Si un servicio de salud no puede ofrecer una técnica incluida en la cartera común en su ámbito geográfico, ¿qué debe hacer?

A) Excluir temporalmente la técnica de la cartera común.
B) Exigir al paciente que localice por sí mismo un centro privado.
C) Establecer mecanismos de canalización y remisión al centro o servicio que pueda facilitarla.
D) Sustituirla necesariamente por cualquier técnica disponible.

8. ¿Con qué alcance territorial debe garantizarse el acceso a las prestaciones de la cartera común?

A) Solo dentro de la comunidad autónoma de residencia.
B) Únicamente en la provincia en la que esté expedida la tarjeta sanitaria.
C) Solo en centros dependientes directamente del Estado.
D) Con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentre la persona usuaria.

9. ¿Quién financia, con carácter general, las prestaciones recogidas en los anexos I a VIII del Real Decreto 1030/2006?

A) Las comunidades autónomas, conforme al sistema de financiación autonómica, sin perjuicio de las competencias estatales y de terceros obligados.
B) Los municipios en los que se ubican los centros sanitarios.
C) Los pacientes mediante una cuota anual obligatoria.
D) Exclusivamente el Ministerio de Sanidad.

10. Cuando exista un tercero obligado al pago, ¿qué actuación corresponde a los servicios de salud?

A) Denegar la asistencia urgente hasta que pague el tercero.
B) Reclamarle el importe de las atenciones o prestaciones sanitarias facilitadas.
C) Cobrar siempre directamente al paciente y no al tercero.
D) Archivar el coste como gasto no recuperable.

11. ¿Qué significa que los servicios de la cartera común sean básicos y comunes?

A) Que únicamente comprenden actuaciones de atención primaria.
B) Que pueden ser eliminados libremente por cada comunidad autónoma.
C) Que son necesarios para una atención adecuada, integral y continuada a todas las personas usuarias del SNS.
D) Que solo se prestan cuando no exista seguro privado.

12. La continuidad asistencial de la cartera común debe garantizarse:

A) Solo durante el ingreso hospitalario.
B) Únicamente entre centros de una misma zona básica.
C) Solo cuando el paciente lo solicite por escrito.
D) Con independencia del nivel asistencial en el que se atienda al paciente en cada momento.

13. ¿Quién debe realizar las prestaciones sanitarias de la cartera común?

A) Profesionales sanitarios titulados, sin perjuicio de la colaboración de otros profesionales dentro de sus competencias.
B) Cualquier persona empleada en un centro sanitario, aunque carezca de habilitación.
C) Exclusivamente personal médico.
D) Solo personal funcionario de carrera.

14. Entre los deberes de los profesionales sanitarios se encuentra:

A) Utilizar siempre la técnica más costosa disponible.
B) Hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos.
C) Evitar informar al paciente para agilizar la asistencia.
D) Derivar toda decisión clínica a la dirección económica del centro.

15. Como regla general, la cartera común se facilitará:

A) En cualquier centro privado elegido libremente, con reembolso automático.
B) Solo en centros de titularidad estatal.
C) En centros, establecimientos y servicios propios o concertados del Sistema Nacional de Salud.
D) Exclusivamente en hospitales universitarios.

16. ¿Cuándo puede reembolsarse una asistencia urgente, inmediata y vital prestada fuera del SNS?

A) Siempre que el paciente prefiera un centro privado.
B) Cuando el centro privado esté en la misma provincia.
C) Solo si la asistencia supera veinticuatro horas.
D) Cuando se compruebe que no pudieron utilizarse oportunamente los medios del SNS y no exista uso desviado o abusivo.

17. Los centros que faciliten prestaciones de la cartera común deberán:

A) Estar debidamente autorizados conforme a la normativa aplicable.
B) Ser necesariamente propiedad de la Administración General del Estado.
C) Carecer de conciertos con entidades públicas.
D) Solicitar autorización distinta para cada paciente.

18. ¿Cuál de los siguientes criterios debe considerarse al definir o actualizar la cartera común?

A) La popularidad de la técnica en redes sociales.
B) La seguridad, eficacia, eficiencia, efectividad, utilidad terapéutica e impacto económico y organizativo.
C) La preferencia comercial del fabricante.
D) La antigüedad del centro que propone la técnica.

19. Si una técnica necesita utilizar un medicamento, antes de su inclusión en la cartera común el medicamento deberá:

A) Encontrarse únicamente en fase preclínica.
B) Ser elaborado necesariamente por un laboratorio público.
C) Estar autorizado para su comercialización y utilizarse conforme a su ficha técnica autorizada.
D) Carecer de indicación terapéutica autorizada.

20. Los productos sanitarios necesarios para una técnica que se pretenda incluir en la cartera deben:

A) Tener únicamente autorización municipal.
B) Haber sido utilizados al menos diez años en otro país.
C) Ser gratuitos para la Administración.
D) Contar con el marcado CE para la indicación correspondiente y cumplir la normativa aplicable.

21. Para incluir una técnica en la cartera común, esta debe contribuir eficazmente, entre otros fines, a:

A) La prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades, o a disminuir el dolor y el sufrimiento.
B) La mejora estética sin relación con enfermedad o accidente.
C) La realización de actividades de ocio y descanso.
D) La obtención de certificados solicitados por terceros.

22. Además de ser eficaz, una nueva técnica debe aportar respecto de las alternativas existentes:

A) Una mayor complejidad técnica, aunque no mejore resultados.
B) Una mejora demostrada en seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia o utilidad.
C) Un precio superior como indicador de calidad.
D) Una marca comercial diferente, aunque sea equivalente.

23. ¿Qué técnica no debe incluirse en la cartera común?

A) La que mejore la seguridad frente a las alternativas.
B) La que reduzca de forma demostrada el sufrimiento.
C) La que no tenga suficientemente probada su contribución eficaz a la prevención, diagnóstico o tratamiento.
D) La que cumpla la legislación aplicable y aporte utilidad.

24. Una técnica en fase de investigación clínica:

A) Se incluirá automáticamente si la solicita un hospital.
B) Se incorporará siempre a la cartera básica.
C) No podrá utilizarse nunca, ni siquiera en uso compasivo.
D) No se incluirá, salvo que esté autorizada para uso compasivo.

25. ¿Cuál de las siguientes finalidades determina la no inclusión en la cartera común?

A) Las meras actividades de ocio, descanso, confort o mejora estética o cosmética.
B) La rehabilitación después de un accidente.
C) La prevención de enfermedades.
D) La disminución del dolor y el sufrimiento.

26. Los reconocimientos o pruebas biológicas solicitados voluntariamente por interés de terceros:

A) Forman siempre parte de la cartera básica.
B) No se incluyen en la cartera común.
C) Son atención de urgencia.
D) Deben financiarse íntegramente por el servicio de salud.

27. ¿Cuándo puede excluirse una técnica ya incluida en la cartera común?

A) Cuando aumente el número de profesionales formados para aplicarla.
B) Cuando reduzca el tiempo de hospitalización.
C) Cuando se evidencie falta de eficacia, efectividad o eficiencia, o un balance beneficio-riesgo significativamente desfavorable.
D) Cuando su demanda sea elevada.

28. La pérdida de interés sanitario por el desarrollo científico y tecnológico puede dar lugar a:

A) Su conversión automática en prestación farmacéutica.
B) Su mantenimiento obligatorio durante diez años.
C) La transferencia de su financiación a los ayuntamientos.
D) La exclusión de la técnica, tecnología o procedimiento.

29. ¿En qué anexo del Real Decreto 1030/2006 se recoge la prestación de salud pública?

A) En el anexo I.
B) En el anexo IV.
C) En el anexo VIII.
D) En el anexo IX.

30. ¿En qué anexo se recoge la cartera de servicios comunes de atención primaria?

A) En el anexo V.
B) En el anexo II.
C) En el anexo VII.
D) En el anexo IX.

31. La atención especializada se regula en:

A) El anexo I.
B) El anexo VI.
C) El anexo III del Real Decreto 1030/2006.
D) El anexo VIII.

32. La atención de urgencia se encuentra desarrollada en:

A) El anexo II.
B) El anexo VII.
C) El anexo IX.
D) El anexo IV del Real Decreto 1030/2006.

33. La prestación de transporte sanitario se recoge en:

A) El anexo VIII del Real Decreto 1030/2006.
B) El anexo III.
C) El anexo V.
D) El anexo IX exclusivamente.

34. Según la Ley 16/2003, el catálogo de prestaciones del SNS comprende, entre otras:

A) Únicamente atención primaria y hospitalización.
B) Atención sociosanitaria, atención de urgencias y transporte sanitario.
C) Servicios sociales municipales sin contenido sanitario.
D) Solo prestaciones diagnósticas y farmacéuticas.

35. ¿En qué modalidades se articula la cartera común del SNS?

A) Preventiva, hospitalaria y municipal.
B) Estatal, provincial y local.
C) Básica de servicios asistenciales, suplementaria y de servicios accesorios.
D) Urgente, programada y privada.

36. La cartera común básica de servicios asistenciales incluye:

A) Solo la prestación farmacéutica ambulatoria.
B) El transporte no urgente sin prescripción facultativa.
C) Actividades de apoyo no esenciales sujetas a reembolso.
D) Las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y el transporte sanitario urgente, con financiación pública completa.

37. La cartera común suplementaria se caracteriza porque sus prestaciones:

A) Se dispensan de forma ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario.
B) Se prestan exclusivamente durante la hospitalización.
C) Carecen siempre de aportación del usuario.
D) Son actividades no sanitarias de ocio.

38. El transporte sanitario no urgente tiene la consideración de prestación suplementaria cuando:

A) Es solicitado por mera comodidad del usuario.
B) Está sujeto a prescripción facultativa por razones clínicas.
C) Lo autoriza exclusivamente una aseguradora privada.
D) Se realiza siempre dentro del mismo municipio.

39. La cartera común de servicios accesorios incluye:

A) Todas las intervenciones quirúrgicas urgentes.
B) El transporte sanitario urgente.
C) Actividades, servicios o técnicas no esenciales y de apoyo para mejorar una patología crónica, sujetos a aportación o reembolso.
D) La hospitalización en unidades de cuidados intensivos.

40. ¿Cómo se acuerda y aprueba la cartera común del SNS?

A) La aprueba cada ayuntamiento mediante ordenanza.
B) La decide cada hospital por instrucción interna.
C) La aprueba el Congreso mediante ley orgánica para cada prestación.
D) Se acuerda en el Consejo Interterritorial y se aprueba mediante real decreto.

41. ¿Con qué periodicidad debe el Ministerio evaluar los costes de aplicación de la cartera común?

A) Anualmente.
B) Cada cinco años.
C) Solo cuando lo solicite una comunidad autónoma.
D) Nunca, porque la evaluación corresponde exclusivamente a los hospitales.

42. Los costes de una cartera complementaria autonómica serán asumidos:

A) Por los municipios en proporción a su población.
B) Por la comunidad autónoma con cargo a sus propios presupuestos.
C) Íntegramente por el Fondo Social Europeo.
D) Por el paciente en todos los casos.

43. ¿Mediante qué disposición se actualizan los anexos de la cartera común del Real Decreto 1030/2006?

A) Mediante resolución de cada gerencia hospitalaria.
B) Mediante ordenanza municipal.
C) Mediante orden ministerial, previo acuerdo del Consejo Interterritorial.
D) Mediante convenio colectivo.

44. La incorporación o exclusión de técnicas de la cartera exige, con carácter general:

A) Una encuesta vinculante entre pacientes.
B) La aprobación del fabricante.
C) Un acuerdo de las diputaciones provinciales.
D) Evaluación por el Ministerio competente, con participación de los órganos evaluadores previstos.

45. Una técnica se considera relevante a efectos del procedimiento de actualización cuando:

A) Requiere nuevos equipos específicos para su aplicación.
B) Solo cambia el nombre comercial del producto.
C) No afecta a la organización ni a los resultados.
D) Se limita a una modificación técnica menor sin otra relevancia.

46. También se considera relevante una técnica que:

A) Mantiene exactamente los mismos circuitos asistenciales.
B) Modifica significativamente las formas o sistemas organizativos de atención a los pacientes.
C) Solo cambia el color de un dispositivo.
D) No tiene impacto en la práctica clínica.

47. ¿Qué circunstancia convierte una técnica en relevante para su evaluación?

A) Que solo interese al proveedor que la fabrica.
B) Que tenga un nombre comercial registrado.
C) Que afecte a amplios sectores de población o a grupos de riesgo.
D) Que se utilice únicamente con fines docentes sin pacientes.

48. La propuesta de inclusión de una nueva técnica debe acompañarse de:

A) Únicamente un presupuesto del fabricante.
B) Solo un informe de satisfacción de usuarios.
C) Una autorización del ayuntamiento donde se vaya a utilizar.
D) Memoria técnica, repercusiones bioéticas y sociales y memoria económica.

49. Finalizada la tramitación, ¿qué órgano acuerda la propuesta de inclusión o exclusión?

A) La Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación.
B) El Consejo Escolar del centro sanitario.
C) La Agencia Tributaria.
D) La junta de personal de cada hospital.

50. Ante indicios de un balance beneficio-riesgo significativamente desfavorable, el Ministerio puede:

A) Mantener obligatoriamente la técnica hasta la siguiente legislatura.
B) Acordar la exclusión cautelar e iniciar simultáneamente el expediente correspondiente.
C) Trasladar la decisión a cada paciente.
D) Limitarse a informar al fabricante sin adoptar medidas.

TEMA 2. Ley de Salud de la Comunitat Valenciana y organización de la atención sanitaria

51. ¿Cuál es el objeto principal de la Ley 10/2014, de Salud de la Comunitat Valenciana?

A) Regular exclusivamente la sanidad privada.
B) Organizar únicamente los servicios farmacéuticos.
C) Garantizar el derecho a la protección de la salud en la Comunitat Valenciana mediante promoción, prevención, ordenación de la atención y prestaciones necesarias.
D) Crear un sistema sanitario independiente del Sistema Nacional de Salud.

52. ¿Qué corresponde a la Generalitat según el artículo 2 de la Ley 10/2014?

A) Aprobar la cartera común estatal mediante decreto autonómico.
B) Gestionar los servicios sanitarios de todas las comunidades autónomas.
C) Delegar obligatoriamente toda la sanidad en los municipios.
D) Determinar las directrices de actuación de los poderes públicos valencianos en salud y establecer los medios necesarios.

53. ¿Cuál de los siguientes es un principio rector del Sistema Valenciano de Salud?

A) La universalización de la atención sanitaria y la igualdad efectiva de acceso.
B) La selección de pacientes según su capacidad económica.
C) La exclusión de la prevención de las políticas sanitarias.
D) La gestión privada obligatoria de todos los centros.

54. La integración de los componentes del Sistema Valenciano de Salud persigue:

A) Separar completamente atención primaria y especializada.
B) Garantizar la continuidad asistencial con criterios de equidad, calidad y sostenibilidad.
C) Impedir la coordinación con los recursos sociosanitarios.
D) Sustituir la atención clínica por actuaciones administrativas.

55. La visión integral de los problemas de salud debe basarse especialmente en:

A) La atención hospitalaria como único nivel asistencial.
B) La actuación aislada de cada profesional.
C) La atención primaria y el trabajo en equipo mediante redes asistenciales.
D) La derivación automática de todos los pacientes a centros privados.

56. En todos los niveles del Sistema Valenciano de Salud debe velarse por:

A) La subordinación de la intimidad a la rapidez administrativa.
B) La publicidad de todos los datos clínicos.
C) La sustitución sistemática de las decisiones del paciente.
D) La dignidad, la autonomía de la voluntad y la intimidad de la persona.

57. La formación continuada del personal sanitario es considerada por la Ley 10/2014:

A) Un derecho y un deber.
B) Una actividad voluntaria sin relación con la calidad.
C) Una obligación exclusiva del personal directivo.
D) Una competencia reservada a las entidades locales.

58. Entre las competencias sanitarias municipales figura:

A) La aprobación de la cartera común del SNS.
B) La salubridad pública.
C) La autorización estatal de medicamentos.
D) La dirección de todos los hospitales públicos.

59. ¿Qué integra el Sistema Valenciano de Salud?

A) Solo los hospitales de titularidad estatal.
B) Exclusivamente los centros privados sin concierto.
C) Los centros, servicios y establecimientos gestionados bajo responsabilidad de la Generalitat para hacer efectivo el derecho a la salud.
D) Únicamente los servicios de urgencias extrahospitalarias.

60. La gestión y administración del Sistema Valenciano de Salud corresponde:

A) A las diputaciones provinciales.
B) Al Consejo Interterritorial del SNS.
C) A cada colegio profesional sanitario.
D) A la conselleria competente en materia de sanidad.

61. El Sistema Valenciano de Salud debe velar por una atención integral que comprenda:

A) Salud física y mental, promoción, prevención, asistencia, rehabilitación, cronicidad y cuidados paliativos.
B) Solo diagnóstico y tratamiento hospitalario.
C) Únicamente salud pública y vacunación.
D) Exclusivamente asistencia farmacéutica.

62. La cartera de servicios del Sistema Valenciano de Salud está formada por:

A) Solo las prestaciones creadas por los ayuntamientos.
B) La cartera común del SNS y la cartera complementaria autonómica que pueda aprobarse.
C) Exclusivamente la cartera farmacéutica.
D) La suma de las pólizas de seguros privados.

63. Las técnicas incluidas en la cartera valenciana deben responder a criterios de:

A) Rentabilidad comercial exclusiva.
B) Preferencia personal del gestor.
C) Seguridad, eficiencia, utilidad y calidad.
D) Antigüedad del proveedor.

64. La atención sanitaria de calidad debe estar:

A) Centrada únicamente en la reducción del gasto.
B) Organizada sin evaluar resultados.
C) Limitada a la asistencia hospitalaria.
D) Centrada en el paciente y considerar efectividad, eficiencia, accesibilidad, equidad y seguridad.

65. El Plan de Salud de la Comunitat Valenciana es:

A) El instrumento estratégico de planificación y programación de las políticas de salud.
B) Una relación anual de puestos de trabajo.
C) Un reglamento de transporte sanitario.
D) Un registro de historias clínicas.

66. ¿Quién aprueba el Plan de Salud de la Comunitat Valenciana?

A) Les Corts mediante ley orgánica.
B) El Consell, a propuesta de la persona titular de la conselleria competente en sanidad.
C) Cada departamento de salud por separado.
D) El Ministerio de Sanidad sin intervención autonómica.

67. ¿Cómo se ordena territorialmente el Sistema Valenciano de Salud?

A) En partidos judiciales.
B) En distritos universitarios.
C) En departamentos de salud, equivalentes a las áreas de salud de la legislación básica estatal.
D) En comarcas farmacéuticas exclusivamente.

68. Los departamentos de salud son:

A) Órganos estatales de inspección.
B) Asociaciones privadas de pacientes.
C) Unidades dedicadas exclusivamente a la contratación.
D) Las estructuras fundamentales y demarcaciones geográficas del Sistema Valenciano de Salud.

69. El Mapa Sanitario de la Comunitat Valenciana es:

A) El instrumento estratégico para ordenar el territorio en departamentos y zonas básicas de salud.
B) El registro de vehículos de transporte sanitario.
C) El catálogo de especialidades médicas.
D) El inventario de personal de cada hospital.

70. ¿Qué órgano formula las directrices de política de salud dentro del departamento?

A) El consejo escolar municipal.
B) El consejo de dirección del departamento de salud.
C) La comisión provincial de urbanismo.
D) El colegio oficial de médicos.

71. La dirección y gestión integrada de los recursos del departamento corresponde:

A) Al Consejo Interterritorial del SNS.
B) A la diputación provincial.
C) A la gerencia del departamento de salud.
D) A la junta de personal exclusivamente.

72. El Sistema de Información Poblacional (SIP) es:

A) Un registro exclusivamente farmacéutico.
B) Una base de datos municipal de empadronamiento.
C) Un sistema privado de facturación.
D) El registro administrativo corporativo que contiene información administrativa y sanitaria de residentes y de otras personas atendidas.

73. Uno de los objetivos del SIP es:

A) La correcta identificación y registro de pacientes y personas usuarias.
B) Asignar sanciones disciplinarias al personal.
C) Aprobar el Plan de Salud.
D) Autorizar la comercialización de medicamentos.

74. La Tarjeta Sanitaria Individual es un documento:

A) Transferible entre familiares convivientes.
B) Personal e intransferible que identifica y acredita a su titular para acceder a las prestaciones que le correspondan.
C) De uso exclusivo en hospitales.
D) Expedido por el ayuntamiento.

75. La vigilancia en salud pública consiste en:

A) Realizar únicamente inspecciones laborales.
B) Gestionar exclusivamente las listas de espera.
C) Recoger, analizar, interpretar y difundir información sobre el estado de salud y sus condicionantes.
D) Autorizar el ingreso hospitalario de cada paciente.

76. El Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida en Salud Pública funciona:

A) Solo en horario administrativo.
B) Únicamente durante campañas de vacunación.
C) Solo cuando lo solicite un municipio.
D) De manera continua, las veinticuatro horas del día.

77. ¿Qué principio protege el artículo 41 de la Ley 10/2014?

A) La confidencialidad de los datos de salud y la intimidad corporal del paciente.
B) La publicidad general de la historia clínica.
C) El acceso libre de cualquier empleado a los datos.
D) La grabación automática de toda asistencia.

78. La información asistencial al paciente debe ser:

A) Exclusivamente técnica y sin adaptación.
B) Veraz, comprensible y adecuada a sus necesidades.
C) Facilitada solo después del alta.
D) Sustituida por un formulario estándar sin explicación.

79. ¿En qué caso debe constar por escrito el consentimiento informado?

A) En la toma rutinaria de constantes vitales.
B) En cualquier conversación con el personal sanitario.
C) En intervenciones quirúrgicas y procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasores.
D) En la entrega de una cita administrativa.

80. ¿Cuál es la finalidad principal de la historia clínica?

A) Servir exclusivamente para la facturación.
B) Sustituir el consentimiento informado.
C) Publicar estadísticas nominativas.
D) Facilitar la asistencia e integrar la información útil sobre el estado de salud del paciente.

81. Los centros sanitarios deben disponer de:

A) Una historia clínica única por paciente.
B) Una historia distinta por cada profesional que atienda al paciente.
C) Una historia solo para los ingresos hospitalarios.
D) Una historia clínica pública y accesible a cualquier persona.

82. En un traslado urgente a un centro que no pueda acceder a la historia clínica electrónica:

A) No se remitirá información por razones de confidencialidad.
B) Se remitirá una copia completa en papel para garantizar el conocimiento de la situación clínica actualizada.
C) Se esperará al alta para enviar los datos.
D) Solo se comunicará el nombre del paciente.

83. El derecho de acompañamiento puede ejercerse también:

A) Solo en consultas de atención primaria.
B) Nunca durante el transporte sanitario.
C) En ambulancias y UVI móviles, siempre que las circunstancias lo permitan y no exista contraindicación médica.
D) Únicamente por representantes legales.

84. Entre los deberes del personal sanitario se encuentra:

A) Difundir los datos clínicos dentro y fuera del centro.
B) Desatender las decisiones libres del paciente.
C) Evitar registrar las actuaciones realizadas.
D) Cumplimentar la documentación clínica y guardar secreto sobre la información a la que acceda.

85. Entre los deberes de pacientes y personas usuarias figura:

A) Hacer buen uso de las prestaciones asistenciales según sus necesidades y la disponibilidad del sistema.
B) Elegir cualquier recurso de emergencia por mera conveniencia.
C) Negarse a identificarse en todos los casos.
D) Exigir pruebas sin indicación sanitaria.

86. Según el Decreto 74/2007, la estructura territorial y funcional básica de organización asistencial es:

A) La provincia sanitaria estatal.
B) El departamento de salud.
C) El partido judicial.
D) La mancomunidad farmacéutica.

87. La atención primaria actúa ordinariamente como:

A) Nivel reservado exclusivamente a la rehabilitación.
B) Servicio subordinado a los ayuntamientos.
C) Puerta de entrada al sistema, sin perjuicio del acceso urgente cuando exista necesidad inmediata.
D) Atención limitada a pacientes hospitalizados.

88. La coordinación de los servicios sanitarios del departamento pretende:

A) Mantener aislados los distintos servicios.
B) Impedir las interconsultas.
C) Sustituir los protocolos por decisiones administrativas individuales.
D) Asegurar una oferta asistencial integrada y la continuidad entre profesionales y niveles.

89. La gestión de la calidad en el Decreto 74/2007 se apoya, entre otros instrumentos, en:

A) Comisiones clínicas, protocolos, evaluación y revisión de resultados.
B) La ausencia de registros para reducir burocracia.
C) La supresión de controles de seguridad.
D) La exclusión de los profesionales de la mejora asistencial.

90. El catálogo de prestaciones del reglamento valenciano incluye:

A) Solo atención hospitalaria y farmacia.
B) Atención primaria, especializada, sociosanitaria, urgencias y emergencias, y transporte sanitario, entre otras.
C) Únicamente salud pública municipal.
D) Exclusivamente prestaciones privadas.

91. La atención ambulatoria se caracteriza por:

A) Exigir siempre ingreso hospitalario.
B) Limitarse al transporte sanitario.
C) Prestarse sin internamiento e incluir atención primaria y especializada ambulatoria.
D) Prestarse únicamente en el domicilio.

92. Los centros de salud y consultorios constituyen principalmente:

A) Órganos sancionadores.
B) Centros exclusivos de alta complejidad quirúrgica.
C) Unidades administrativas sin actividad sanitaria.
D) Dispositivos de proximidad para el acceso y la prestación de atención primaria.

93. Las unidades de apoyo de atención primaria permiten incorporar prestaciones como:

A) Rehabilitación básica, salud mental, odontología o salud sexual y reproductiva.
B) Cirugía cardiaca de alta complejidad exclusivamente.
C) Inspección tributaria.
D) Gestión urbanística municipal.

94. Los centros sanitarios integrados tienen como finalidad:

A) Sustituir todos los hospitales.
B) Acercar a la población prestaciones de distintos niveles y favorecer su coordinación.
C) Prestar únicamente servicios no sanitarios.
D) Eliminar la atención primaria de la zona.

95. Los Servicios de Emergencias Sanitarias responden a urgencias, emergencias y catástrofes:

A) Solo en horario de atención primaria.
B) Únicamente si lo autoriza el ayuntamiento.
C) Las veinticuatro horas del día, todos los días del año, bajo coordinación de los CICU.
D) Exclusivamente durante grandes catástrofes.

96. ¿Cuál es el objeto del Decreto 9/2026?

A) Regular exclusivamente el transporte sanitario aéreo.
B) Aprobar el régimen sancionador farmacéutico.
C) Crear el Sistema Nacional de Salud.
D) Establecer y regular la estructura, organización y funcionamiento de la Atención Primaria y Comunitaria del Sistema Valenciano de Salud.

97. El Decreto 9/2026 se aplica:

A) Al ámbito de la Atención Primaria y Comunitaria del Sistema Valenciano de Salud.
B) A todos los servicios sanitarios privados de España.
C) Solo a los hospitales universitarios.
D) Exclusivamente a los servicios municipales de salud.

98. La Atención Primaria y Comunitaria se define en el Decreto 9/2026 como:

A) Un nivel secundario reservado a la asistencia no clínica.
B) El eje fundamental e inicial de atención, gestor y coordinador de casos y regulador de flujos.
C) Un servicio de acceso exclusivo por derivación hospitalaria.
D) Una estructura dedicada únicamente a tareas administrativas.

99. Entre los valores y principios rectores de la Atención Primaria y Comunitaria se encuentran:

A) Selección económica de pacientes y competencia entre zonas.
B) Centralización hospitalaria y ausencia de participación comunitaria.
C) Accesibilidad, equidad, eficiencia, sostenibilidad, coordinación y continuidad asistencial.
D) Atención fragmentada y limitada a procesos agudos.

100. La Atención Primaria y Comunitaria se organiza territorialmente en:

A) Provincias, partidos judiciales y distritos escolares.
B) Municipios y diputaciones exclusivamente.
C) Áreas comerciales y zonas farmacéuticas privadas.
D) Agrupaciones sanitarias interdepartamentales, departamentos de salud y zonas básicas de salud.

Test Soluciones Tema 1-2 Normativa Sanitaria

JOSEP MANUEL HERNÁNDEZ PÉREZ

EL CUESTIONARIO CONSTA DE 100 PREGUNTAS

SOLUCIONES Y FUNDAMENTO NORMATIVO

La tabla identifica la letra correcta y reproduce la respuesta para facilitar la corrección. Las referencias normativas deben interpretarse conforme al texto vigente aplicable en la fecha del examen.

Pregunta	Respuesta correcta	Artículo / fundamento normativo
1	A) Establecer el contenido de la cartera de servicios comunes de las prestaciones sanitarias.	Art. 1.1 del Real Decreto 1030/2006
2	B) Fijar las bases del procedimiento de actualización de la cartera de servicios comunes.	Art. 1.2 del Real Decreto 1030/2006
3	C) Como el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias.	Art. 2.1 del Real Decreto 1030/2006
4	D) Las personas contempladas en el artículo 3.1 de la Ley 16/2003.	Art. 2.2 del Real Decreto 1030/2006
5	A) Las administraciones sanitarias, dentro de sus respectivas competencias.	Art. 2.3 del Real Decreto 1030/2006
6	B) Una indicación clínica y sanitaria.	Art. 2.4 del Real Decreto 1030/2006
7	C) Establecer mecanismos de canalización y remisión al centro o servicio que pueda facilitarla.	Art. 2.4 del Real Decreto 1030/2006
8	D) Con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentre la persona usuaria.	Art. 2.5 del Real Decreto 1030/2006
9	A) Las comunidades autónomas, conforme al sistema de financiación autonómica, sin perjuicio de las competencias estatales y de terceros obligados.	Art. 2.6 del Real Decreto 1030/2006
10	B) Reclamarle el importe de las atenciones o prestaciones sanitarias facilitadas.	Art. 2.7 y anexo IX del Real Decreto 1030/2006
11	C) Que son necesarios para una atención adecuada, integral y continuada a todas las personas usuarias del SNS.	Art. 3.1 del Real Decreto 1030/2006
12	D) Con independencia del nivel asistencial en el que se atienda al paciente en cada momento.	Art. 3.2 del Real Decreto 1030/2006
13	A) Profesionales sanitarios titulados, sin perjuicio de la colaboración de otros profesionales dentro de sus competencias.	Art. 4.1 del Real Decreto 1030/2006
14	B) Hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos.	Art. 4.2 del Real Decreto 1030/2006
15	C) En centros, establecimientos y servicios propios o concertados del Sistema Nacional de Salud.	Art. 4.3 del Real Decreto 1030/2006
16	D) Cuando se compruebe que no pudieron utilizarse oportunamente los medios del SNS y no exista uso desviado o abusivo.	Art. 4.3 del Real Decreto 1030/2006
17	A) Estar debidamente autorizados conforme a la normativa aplicable.	Art. 4.4 del Real Decreto 1030/2006
18	B) La seguridad, eficacia, eficiencia, efectividad, utilidad terapéutica e impacto económico y organizativo.	Art. 5.1 del Real Decreto 1030/2006
19	C) Estar autorizado para su comercialización y utilizarse conforme a su ficha técnica autorizada.	Art. 5.2.a del Real Decreto 1030/2006
20	D) Contar con el marcado CE para la indicación correspondiente y cumplir la normativa aplicable.	Art. 5.2.b del Real Decreto 1030/2006
21	A) La prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades, o a disminuir el dolor y el sufrimiento.	Art. 5.3.a del Real Decreto 1030/2006
22	B) Una mejora demostrada en seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia o utilidad.	Art. 5.3.b del Real Decreto 1030/2006
23	C) La que no tenga suficientemente probada su contribución eficaz a la prevención, diagnóstico o tratamiento.	Art. 5.4.a.1.º del Real Decreto 1030/2006
24	D) No se incluirá, salvo que esté autorizada para uso compasivo.	Art. 5.4.a.2.º del Real Decreto 1030/2006
25	A) Las meras actividades de ocio, descanso, confort o mejora estética o cosmética.	Art. 5.4.a.4.º del Real Decreto 1030/2006
26	B) No se incluyen en la cartera común.	Art. 5.4.b del Real Decreto 1030/2006
27	C) Cuando se evidencie falta de eficacia, efectividad o eficiencia, o un balance beneficio-riesgo significativamente desfavorable.	Art. 5.5.a del Real Decreto 1030/2006
28	D) La exclusión de la técnica, tecnología o procedimiento.	Art. 5.5.b del Real Decreto 1030/2006
29	A) En el anexo I.	Art. 6 y anexo I del Real Decreto 1030/2006
30	B) En el anexo II.	Art. 6 y anexo II del Real Decreto 1030/2006
31	C) El anexo III del Real Decreto 1030/2006.	Art. 6 y anexo III del Real Decreto 1030/2006
32	D) El anexo IV del Real Decreto 1030/2006.	Art. 6 y anexo IV del Real Decreto 1030/2006
33	A) El anexo VIII del Real Decreto 1030/2006.	Art. 6 y anexo VIII del Real Decreto 1030/2006

Pregunta	Respuesta correcta	Artículo / fundamento normativo
34	B) Atención sociosanitaria, atención de urgencias y transporte sanitario.	Art. 7.1 de la Ley 16/2003
35	C) Básica de servicios asistenciales, suplementaria y de servicios accesorios.	Art. 8.2 de la Ley 16/2003
36	D) Las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y el transporte sanitario urgente, con financiación pública completa.	Art. 8 bis.1 de la Ley 16/2003
37	A) Se dispensan de forma ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario.	Art. 8 ter.1 de la Ley 16/2003
38	B) Está sujeto a prescripción facultativa por razones clínicas.	Art. 8 ter.3 de la Ley 16/2003
39	C) Actividades, servicios o técnicas no esenciales y de apoyo para mejorar una patología crónica, sujetos a aportación o reembolso.	Art. 8 quáter.1 de la Ley 16/2003
40	D) Se acuerda en el Consejo Interterritorial y se aprueba mediante real decreto.	Art. 8.3 de la Ley 16/2003
41	A) Anualmente.	Art. 8.4 de la Ley 16/2003
42	B) Por la comunidad autónoma con cargo a sus propios presupuestos.	Art. 8 quinquies.7 de la Ley 16/2003
43	C) Mediante orden ministerial, previo acuerdo del Consejo Interterritorial.	Art. 7.1 del Real Decreto 1030/2006
44	D) Evaluación por el Ministerio competente, con participación de los órganos evaluadores previstos.	Art. 7.2 del Real Decreto 1030/2006
45	A) Requiere nuevos equipos específicos para su aplicación.	Art. 7.3.c del Real Decreto 1030/2006
46	B) Modifica significativamente las formas o sistemas organizativos de atención a los pacientes.	Art. 7.3.d del Real Decreto 1030/2006
47	C) Que afecte a amplios sectores de población o a grupos de riesgo.	Art. 7.3.e del Real Decreto 1030/2006
48	D) Memoria técnica, repercusiones bioéticas y sociales y memoria económica.	Art. 8.3 del Real Decreto 1030/2006
49	A) La Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación.	Art. 8.4 y art. 9 del Real Decreto 1030/2006
50	B) Acordar la exclusión cautelar e iniciar simultáneamente el expediente correspondiente.	Art. 8.6 del Real Decreto 1030/2006
51	C) Garantizar el derecho a la protección de la salud en la Comunitat Valenciana mediante promoción, prevención, ordenación de la atención y prestaciones necesarias.	Art. 1 de la Ley 10/2014
52	D) Determinar las directrices de actuación de los poderes públicos valencianos en salud y establecer los medios necesarios.	Art. 2 de la Ley 10/2014
53	A) La universalización de la atención sanitaria y la igualdad efectiva de acceso.	Art. 3.1.a de la Ley 10/2014
54	B) Garantizar la continuidad asistencial con criterios de equidad, calidad y sostenibilidad.	Art. 3.1.f de la Ley 10/2014
55	C) La atención primaria y el trabajo en equipo mediante redes asistenciales.	Art. 3.1.g de la Ley 10/2014
56	D) La dignidad, la autonomía de la voluntad y la intimidad de la persona.	Art. 3.1.j de la Ley 10/2014
57	A) Un derecho y un deber.	Art. 3.1.o de la Ley 10/2014
58	B) La salubridad pública.	Art. 6.2.a de la Ley 10/2014
59	C) Los centros, servicios y establecimientos gestionados bajo responsabilidad de la Generalitat para hacer efectivo el derecho a la salud.	Art. 7.1 de la Ley 10/2014
60	D) A la conselleria competente en materia de sanidad.	Art. 7.2 de la Ley 10/2014
61	A) Salud física y mental, promoción, prevención, asistencia, rehabilitación, cronicidad y cuidados paliativos.	Art. 8.3.a de la Ley 10/2014
62	B) La cartera común del SNS y la cartera complementaria autonómica que pueda aprobarse.	Art. 9.1 de la Ley 10/2014
63	C) Seguridad, eficiencia, utilidad y calidad.	Art. 9.2 de la Ley 10/2014
64	D) Centrada en el paciente y considerar efectividad, eficiencia, accesibilidad, equidad y seguridad.	Art. 10.1 de la Ley 10/2014
65	A) El instrumento estratégico de planificación y programación de las políticas de salud.	Art. 12.1 de la Ley 10/2014
66	B) El Consell, a propuesta de la persona titular de la conselleria competente en sanidad.	Art. 12.5 de la Ley 10/2014
67	C) En departamentos de salud, equivalentes a las áreas de salud de la legislación básica estatal.	Art. 13.1 de la Ley 10/2014
68	D) Las estructuras fundamentales y demarcaciones geográficas del Sistema Valenciano de Salud.	Art. 13.2 de la Ley 10/2014
69	A) El instrumento estratégico para ordenar el territorio en departamentos y zonas básicas de salud.	Art. 14 de la Ley 10/2014
70	B) El consejo de dirección del departamento de salud.	Art. 15.1 de la Ley 10/2014
71	C) A la gerencia del departamento de salud.	Art. 15.2 de la Ley 10/2014

Pregunta	Respuesta correcta	Artículo / fundamento normativo
72	D) El registro administrativo corporativo que contiene información administrativa y sanitaria de residentes y de otras personas atendidas.	Art. 17.1 de la Ley 10/2014
73	A) La correcta identificación y registro de pacientes y personas usuarias.	Art. 17.2.a de la Ley 10/2014
74	B) Personal e intransferible que identifica y acredita a su titular para acceder a las prestaciones que le correspondan.	Art. 19.1 de la Ley 10/2014
75	C) Recoger, analizar, interpretar y difundir información sobre el estado de salud y sus condicionantes.	Art. 23.1 de la Ley 10/2014
76	D) De manera continua, las veinticuatro horas del día.	Art. 25.2 de la Ley 10/2014
77	A) La confidencialidad de los datos de salud y la intimidad corporal del paciente.	Art. 41 de la Ley 10/2014
78	B) Veraz, comprensible y adecuada a sus necesidades.	Art. 42.2 de la Ley 10/2014
79	C) En intervenciones quirúrgicas y procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasores.	Art. 43.2 de la Ley 10/2014
80	D) Facilitar la asistencia e integrar la información útil sobre el estado de salud del paciente.	Art. 46.1 de la Ley 10/2014
81	A) Una historia clínica única por paciente.	Art. 46.1 de la Ley 10/2014
82	B) Se remitirá una copia completa en papel para garantizar el conocimiento de la situación clínica actualizada.	Art. 46.7 de la Ley 10/2014
83	C) En ambulancias y UVI móviles, siempre que las circunstancias lo permitan y no exista contraindicación médica.	Art. 50 bis de la Ley 10/2014
84	D) Cumplimentar la documentación clínica y guardar secreto sobre la información a la que acceda.	Art. 52.2.d y f de la Ley 10/2014
85	A) Hacer buen uso de las prestaciones asistenciales según sus necesidades y la disponibilidad del sistema.	Art. 53.1.a de la Ley 10/2014
86	B) El departamento de salud.	Art. 1 del Decreto 74/2007
87	C) Puerta de entrada al sistema, sin perjuicio del acceso urgente cuando exista necesidad inmediata.	Arts. 6 y 11 del Decreto 74/2007
88	D) Asegurar una oferta asistencial integrada y la continuidad entre profesionales y niveles.	Art. 7 del Decreto 74/2007
89	A) Comisiones clínicas, protocolos, evaluación y revisión de resultados.	Art. 9 del Decreto 74/2007
90	B) Atención primaria, especializada, sociosanitaria, urgencias y emergencias, y transporte sanitario, entre otras.	Art. 10 del Decreto 74/2007
91	C) Prestarse sin internamiento e incluir atención primaria y especializada ambulatoria.	Art. 11 del Decreto 74/2007
92	D) Dispositivos de proximidad para el acceso y la prestación de atención primaria.	Art. 12 del Decreto 74/2007
93	A) Rehabilitación básica, salud mental, odontología o salud sexual y reproductiva.	Art. 13 del Decreto 74/2007
94	B) Acercar a la población prestaciones de distintos niveles y favorecer su coordinación.	Art. 14 del Decreto 74/2007
95	C) Las veinticuatro horas del día, todos los días del año, bajo coordinación de los CICU.	Art. 21.3 del Decreto 74/2007
96	D) Establecer y regular la estructura, organización y funcionamiento de la Atención Primaria y Comunitaria del Sistema Valenciano de Salud.	Art. 1 del Decreto 9/2026
97	A) Al ámbito de la Atención Primaria y Comunitaria del Sistema Valenciano de Salud.	Art. 2 del Decreto 9/2026
98	B) El eje fundamental e inicial de atención, gestor y coordinador de casos y regulador de flujos.	Art. 3.1 del Decreto 9/2026
99	C) Accesibilidad, equidad, eficiencia, sostenibilidad, coordinación y continuidad asistencial.	Art. 3.2 del Decreto 9/2026
100	D) Agrupaciones sanitarias interdepartamentales, departamentos de salud y zonas básicas de salud.	Art. 5 del Decreto 9/2026